创新药跨部门评价规则差异与协同治理

王孝炯[1*]，陈海婷[1,2]，刘中全[3]

（1. 中国科学院科技战略咨询研究院，北京 100190；

2. 中国科学院大学公共政策与管理学院，北京 100049；

3. 国家发展和改革委员会创新驱动发展中心，北京 100038）

摘要：创新药研发投入大、周期长，上市审评、医保准入与临床使用环节评价规则的衔接程度，直接影响企业对证据要求的预期及创新成果的转化应用。基于“制度逻辑—组织注意力”分析框架，以药监、医保、卫健三部门 2017—2026 年 51 个政策来源的 4 481 条句段为样本，运用大语言模型对安全性、有效性、经济性、创新性和公平性进行编码，以 466 条人工标注句段检验编码质量，并结合政策条文与访谈资料比较三部门的注意力配置与证据要求。研究发现：药监局的安全性与有效性合计占 68.38%，医保局的经济性占 76.48%，卫健委的安全性和经济性分别占 39.37%和 28.35%；药监局与医保局的主要关注维度在多种稳健性检验下保持稳定；同一维度下，三部门在评价对象、比较药品与证据要求上存在差异，评价结论的跨环节使用须以适用条件核对为前提。据此，从比较药品与证据要求的前置沟通、补充研究统筹和临床应用反馈 3 个方面提出跨部门协同路径，以增强评价规则对企业的可预期性，促进创新药研发、准入与使用环节的质效协同。

关键词：创新药评价；跨部门协同；注意力配置；制度逻辑；评价规则可预期性；科技创新治理

中图分类号：G311；R197　　**文献标识码：**A

Cross-departmental Differences in Innovative Drug Evaluation Rules and Collaborative Governance

WANG Xiaojiong[1*], CHEN Haiting[1,2], LIU Zhongquan[3]

(1. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

2. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. Innovation-driven Development Center, National Development and Reform Commission, Beijing 100038, China)

Abstract: Innovative medicines entail long and costly development, and the alignment of evaluation rules across marketing authorization, reimbursement, and clinical use shapes innovators’ expectations of evidence requirements and the translation of innovations into practice. Based on an institutional logics–organizational attention framework, this study analyzes 4 481 passages from 51 policy sources issued by China’s drug regulatory, medical insurance, and health administration departments from 2017 to 2026. A large language model was used to code the passages on five dimensions, namely safety, efficacy, economic value, innovativeness, and equity; coding quality was validated against 466 human-labeled passages, and the findings were interpreted in light of policy provisions and interview materials. The results show that safety and efficacy jointly account for 68.38% of the attention of the National Medical Products Administration, economic value accounts for 76.48% for the National Healthcare Security Administration, and safety and economic value account for 39.37% and 28.35%, respectively, for the National Health Commission. The leading dimensions of the first two departments remain stable across robustness checks. Within the same dimension, the departments differ in evaluation objects, comparators, and evidence requirements; hence, the cross-stage use of evaluation conclusions should be conditioned on verifying their applicability. Accordingly, cross-departmental coordination pathways are proposed in three areas: early communication on comparators and evidence

requirements, coordinated supplementary studies, and feedback from clinical use. These pathways aim to enhance the predictability of evaluation rules for innovators and to promote quality–efficiency coordination across the development, reimbursement, and clinical use of innovative medicines.

Key words: innovative drug evaluation; cross-departmental coordination; attention allocation; institutional logics; predictability of evaluation rules; science and technology innovation governance

基金项目：国家自然科学基金面上项目“中国新兴产业创新政策组合的绩效影响机制研究”（72074204）

创新药是生物医药领域科技创新成果的重要载体，其价值实现须依次经过上市审评、医保准入与医疗机构遴选等环节，各环节依据不同规则对同一产品作出判断。评价规则是否清晰、能否有效衔接，直接影响企业在临床研究设计、比较药品选择与证据准备上的预期。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》[1]提出健全医疗、医保、医药协同发展和治理机制，优化创新药审评审批，健全医保支持创新药的机制。2025 年出台的《支持创新药高质量发展的若干措施》[2]进一步推动研发、准入与使用衔接，同年发布的首版商业健康保险创新药品目录（以下简称商保创新药目录）与新版基本医保目录自 2026 年 1 月 1 日起实施[3，4]。“十四五”期间，我国共批准创新药 230 个，其中 2025 年 76 个[5]；2025 年国家医保药品目录新增 114 种药品，其中 1 类创新药 50 种，首版商保创新药目录纳入 19 种药品[6]。与此同时，当年仍有 10 余个 1 类创新药未通过医保目录专家评审；据国家医保局有关负责人介绍，部分 1 类新药与目录内同类药品重复且临床价值没有提升，部分药品价格超出“保基本”功能定位或与价值不匹配，均未能通过评审[4]。这表明，上市审评与医保准入回答的是不同的价值判断问题，企业如何在研发阶段预判后续环节的证据要求，已成为创新决策中的现实问题。

从科技创新管理视角看，上述问题的实质是跨部门评价规则能否为企业提供稳定、可预期的制度环境。创新政策研究亦指出，影响创新的政策组合往往包括卫生等非创新领域政策，而针对这一更广泛组合的评估与治理机制普遍缺位[7]。创新药从获批上市、纳入医保到进入临床，分别涉及国家药品监督管理局（以下简称药监局）、国家医疗保障局（以下简称医保局）和国家卫生健康委员会（以下简称卫健委）的评价安排，各环节的评价目的与比较药品各有侧重。课题组的专家访谈与调研纪要（I01、I02）显示，获批上市的 1 类创新药未必满足医保评审对临床价值的要求，纳入医保目录的药品在医疗机构的配备使用中亦可能受阻。若各环节所依据的证据及其用途缺乏清晰界定，企业难以判断既有研究能够支撑哪些结论、后续还需补充哪些证据，规则的不确定性便会转化为证据准备中的重复投入。因此，跨部门协同的关键不在于以单一标准取代各部门评价，而在于厘清各环节的证据要求及其衔接条件，在保障评价质量的前提下提高证据使用效率，实现创新药评价的质效协同。

鉴于此，本文从科技创新治理中的跨部门协同视角出发，构建“制度逻辑—组织注意力”分析框架，对三部门 2017—2026 年涉及创新药上市、准入和使用评价的 51 个政策来源进行编码，并结合政策条文与访谈资料，回答以下两个问题：（1）三部门政策文本对安全性、有效性、经济性、创新性和公平性五维评价内容的注意力配置有何差异？（2）在同一维度下，三部门的评价对象、

比较药品与结论用途有何不同，既有评价结论用于后续环节需满足哪些条件，对增强评价规则的可预期性、促进创新药研发与应用衔接有何启示？

1 文献综述

1.1 创新药评价与创新政策的研究脉络

已有关于创新药评价的研究主要围绕价值评估制度、主体互动与政策工具 3 个层面展开。在价值评估方面，孔繁翠[8]比较英、德、法、加四国的创新药价值评估制度，建议建立附加临床收益评估及分级体系；赵华婷等[9]基于法国经验，主张以临床价值分级与再评价支撑医保目录动态调整；艾丹丹等[10]讨论价值评估的多维属性，主张确定公开透明的价值评价标准，以支持基于价值的定价与支付。在主体互动与政策工具方面，王恩楠等[11]运用演化博弈模型分析医保谈判策略，谭清立[12]基于 2014—2022 年生物医药上市公司数据发现医保谈判政策的实施显著增加了企业创新投入，吕倩鹏等[13]对 65 份国家层面创新药研发政策的量化分析发现政策工具内部结构失衡。总体而言，上述研究多聚焦医保准入或研发政策等单一环节，较少在统一框架下比较不同部门对同一药品的评价要求。科技管理研究为此提供了两点启示：刘仁济等[14]指出，政策工具的使用应与创新价值链相匹配，缺乏整体性设计易导致资源的重复投入；宋娇娇等[15]发现，我国科技评价政策中各机构多以自定规则为主，易致碎片化管理，需加强机构协同。洪银兴[16]进一步指出，新技术只有得到应用才能实现其价值，须将科技创新与产业创新融合。对创新药而言，研发阶段形成的证据能否支撑后续支付与临床应用决策，正是评价规则与创新链衔接的具体体现。

1.2 多主体评价差异的既有研究

国际研究表明，比较不同机构的评价结论需区分其评价标准与证据要求。Casilli 等[17]以在意大利申请创新性认定的 189 个药品/适应症为样本，比较法、德、意三国健康技术评估（Health Technology Assessment，HTA）的附加治疗价值评级，发现德法一致率为 82%，意法和意德分别为 52%和 57%；改用综合考虑证据质量的意大利创新性认定结论后，分别升至 72%和 74%。Garau 等[18]针对意大利 19 名患者代表、临床医生和支付方人员的探索性研究发现，临床医生更重视疾病严重性与比较疗效，支付方则更关注未满足需求、比较成本及证据质量。

Källberg 等[19]对欧美药品监管与 HTA 机构 19 名参与者的研究表明，各方对抗生素新颖性的理解标准不一；上市评价与 HTA 之间缺乏处理有限临床数据的共同做法，由此产生的不确定性还传导至支付方与临床医生。Mundy 等[20]指出，HTA 对创新的界定与评价尚不统一，创新因素往往隐含于优先排序及药品定价、报销决策之中。国内研究中，李梦颖等[21]基于制度逻辑理论分析医保谈判药品在医疗机构的配备与使用，揭示了国家逻辑、市场逻辑、社会逻辑与专业逻辑之间的矛盾与耦合。上述研究表明，评价差异根植于各方的评价标准、证据要求与制度环境。蔡乾和等[22]在公共科技成果价值评价研究中提出，应对评价对象和任务分型分类、依情境开展分类评价，并对评价结果规范和有限使用。借鉴这一思路，上市审评、医保准入与临床使用可视为针对同一

创新成果、服务于不同任务的分类评价；但药品评价具有法定程序与专门技术规则，与公共科技成果评价的任务不同，仍需结合药品政策规则展开比较。

1.3 既有研究与本文定位

既有研究已讨论政府在医疗与医保治理中的主动管理角色[23]及健康技术评估在医保目录调整中的应用[24]，国际研究亦比较了不同国家 HTA 结论的一致性[17]与监管、HTA 机构对新颖性的理解[19]。然而，现有文献或从医保准入角度讨论创新药价值评估，或从政策工具角度分析研发支持政策；创新政策组合研究亦多集中于治理层级维度，对不同政策领域之间组合的探讨较少[25]。既有研究较少在统一评价维度下比较药品注册、医保准入与临床使用主管部门的注意力配置，也较少从企业证据准备的角度考察跨环节评价规则的衔接。同一评价维度可能服务于不同决策，仅比较注意力占比难以揭示既有证据用于后续环节的条件。基于此，本文以五维框架比较三部门的注意力配置及维度共现，结合具体条文分析评价对象、比较药品、证据要求与结论用途，并从证据适用条件出发，探讨增强评价规则可预期性的跨部门协同路径。

2 理论基础与分析框架

2.1 核心概念与理论逻辑

本文以药品注册分类界定创新药。《药品注册管理办法》[26]将中药、化学药和生物制品分别划分为创新药、改良型新药等类别；《化学药品注册分类及申报资料要求》[27]将化学药品 1 类界定为境内外均未上市、含有新的结构明确且具有药理作用的化合物，并具有临床价值的创新药。《支持创新药高质量发展的若干措施》[2]（以下简称《若干措施》）提出增设商保创新药目录，重点纳入创新程度高、临床价值大、患者获益显著且超出基本医保保障范围的创新药。可以看出，注册分类兼顾化合物新颖性与临床价值，医保支付则进一步考虑患者获益与保障范围。由于新药常依据较少受试者和较少关键试验获批，且多数试验缺乏阳性对照[28]，各方对创新的界定与评价也不尽一致[20]，其价值判断在各环节之间更难直接互认。除突破性治疗等加快上市程序[26]和商保创新药目录等专门安排外，创新药主要适用通用的药品评价规则，故本文比较三部门评价创新药所依据的政策规则，而不限于以“创新药”命名的文件。相应地，本文所称“创新药评价”，是指三部门政策文本中适用于创新药上市审评、医保准入和临床使用的评价规则及其注意力配置，而非具体品种的评审结论。这些规则构成企业安排研发与证据准备的重要制度依据。据此，本文比较各环节对企业证据准备的要求，并探讨如何通过比较药品沟通、补充研究与临床应用反馈增强评价规则的可预期性，促进创新药研发、准入与使用的衔接。

制度逻辑视角有助于解释三部门对创新药价值判断的差异。该视角强调实践、价值和规则与认知、行动及制度环境之间的关联，并关注多种制度逻辑之间的冲突与一致如何影响组织行为；医疗卫生领域即同时受市场逻辑、国家逻辑和医学专业逻辑塑造[29]。Flanagan 等[7]亦指出，政策组合中的张力主要源于政策理念、目标与实施方式的冲突。在创新药领域，药品注册、医保准入和临床使用分别由药监局、医保局和卫健委主导，构成服务于不同决策目标的制度安排；三者作

用于同一创新产品，使企业面临多重制度要求。本文据此考察这些目标在评价对象、证据要求和结论用途上的具体体现。

制度逻辑揭示了三部门决策目标的差异，而这种差异如何转化为政策文本注意力配置的差异，可由注意力基础观加以解释。Thornton 和 Ocasio[29]指出，制度逻辑使决策者的注意力集中于与主导逻辑相一致的议题和解决方案。Ocasio[30]认为，决策者做什么取决于其关注的议题与应对方案，关注内容随所处情境而变化（情境注意力），而情境本身取决于组织的规则、资源与社会关系如何调节议题、应对方案与决策者的分布（注意力的结构性分配）。练宏[31]指出，注意力分配是组织环境、制度环境和社会环境的产物；李梦颖等[21]在分析国谈药落地时，为国家、市场、社会和专业逻辑分别界定了注意力分配取向。由于三部门的决策情境及规则与资源约束不同，其政策文本对五维评价内容的注意力占比可能存在差异。

政策文本的内容选择为测量上述差异提供了途径。政策文本分析是测量政府注意力最常用的方法，可通过词汇、句段和主题等要素量化注意力配置[32]：文宏[33]以关键词所在句段及其语境测量基本公共服务注意力；陈星平等[34]按同一句段在同一维度计一次、在不同维度分别计数的原则比较关注内容的构成。借鉴上述做法，本文将“部门注意力配置差异”界定为三部门对五维评价内容注意力占比的差异，并以“注意力占比”衡量，即某维度编码为 1 的句段数占该部门五个维度编码为 1 的句段数之和的比例；同一句段可计入多个维度，但在同一维度至多计一次。在比较注意力配置的基础上，本文进一步结合条文与访谈，考察同一维度下证据要求及其用途的差异，以识别跨环节证据准备中需要协调的具体事项。

2.2 三种制度逻辑的操作化

借鉴李梦颖等[21]按目标取向刻画医药领域各制度逻辑的思路，本文依据三部门核心文件的政策目标概括其制度逻辑。《药品注册管理办法》[26]要求保证药品安全、有效和质量可控，并明确临床价值导向，体现科学—安全逻辑。《基本医疗保险用药管理暂行办法》[35]（以下简称《暂行办法》）将提高基金使用效益列为制定目的之一，并以临床必需、安全有效、价格合理为纳入目录的基本条件，体现经济—效率逻辑。《药品临床综合评价管理指南（2021 年版 试行）》[36]（以下简称《管理指南》）强调保障基本用药供应、规范使用并满足用药需求，体现公共服务逻辑。三种逻辑概括了各部门的主要决策任务，彼此并不排斥，安全有效与临床价值是三部门共同关注的基础（表 1、图 1）。据此提出预期：药监局以安全性、有效性为主，医保局以经济性为主，卫健委在安全性与公平性上相对突出。

表 1　创新药评价中的三种制度逻辑

制度逻辑	对应部门	政策目标	评价要求	比较问题
科学—安全逻辑	药监局	保证安全、有效 和质量可控	以临床价值为导向； 提供相应证据	证据如何支持 上市决策
经济—效率逻辑	医保局	提高基金使用效益	临床必需、安全有效、 价格合理	评价结论如何用于 准入和支付
公共服务逻辑	卫健委	保障供应、规范使用， 满足用药需求	安全性、有效性、经济性、 创新性、适宜性、可及性	综合评价如何 指导临床使用

资料来源：作者整理。

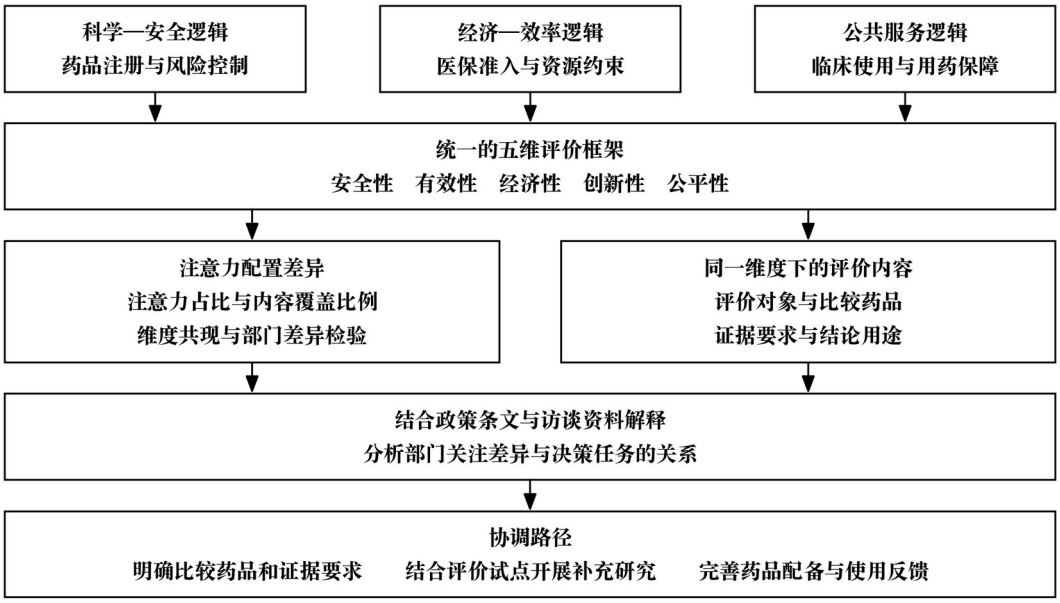


图 1　“制度逻辑—组织注意力”分析框架

资料来源：作者绘制。

3 资料来源

3.1 政策文本

研究时段为 2017 年至 2026 年 7 月，研究对象为公开的药品评价政策及配套官方材料。2017 年，人力资源社会保障部将 36 种谈判药品纳入医保目录乙类范围[37]，中办、国办印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》[38]，统筹部署审评审批、医保支付与医疗机构使用新药，故以 2017 年作为三部门政策的共同起点。

参照吕倩鹏等[13]以部门官网与北大法宝相结合检索、剔除无实质内容和重复文件的做法，以“创新药”“合理用药”“双通道”“药品注册”“药品审评审批”“医保药品目录”“药品临床综合评价”为标题关键词，于 2026 年 7 月 6 日在北大法宝 V6 中央法规数据库精确检索 2017—2026 年的部门规章、部门规范性文件和部门工作文件，并从相关部门官网补充附件及配套材料。在此基础上，剔除纯药品清单、年度审评报告、按疾病诊断相关分组和按病种分值付费的技术规范、逐年临床用药手册，以及已有正式版的征求意见稿。

最终纳入 51 个政策来源，其中药监局 17 个、医保局 24 个、卫健委 10 个（示例见表 2，完整清单见补充材料 B）；党中央、国务院或中办、国办发布的 4 份文件作为共同制度背景。一个政策来源可包含通知、附件或配套官方问答，同一正文重复发布仅计一次；联合发文按制度系统归属计入一个部门，并通过剔除联合文本检验该处理的影响。卫健委对药品临床使用的评价主要体现于药事管理、处方审核和合理用药等文件，故将此类文件纳入。由于纳入来源包含适用于全部药品的文件，各部门组文本中含“创新药”一词的句段分别为药监局 98 条、医保局 144 条、卫健委 0 条。

表 2　三部门政策来源示例

部门	名称	文号	发文日期
药监局	药品注册管理办法	国家市场监督管理总局令第 27 号	2020 年 1 月
	优化创新药临床试验审评审批试点工作方案	国药监药注〔2024〕21 号	2024 年 7 月
	…	…	…
	罕见疾病创新药物研发鼓励试点计划（“关爱计划-延伸”）	药审业〔2026〕177 号	2026 年 5 月
医保局	基本医疗保险用药管理暂行办法	国家医疗保障局令第 1 号	2020 年 7 月
	关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见	医保发〔2021〕28 号	2021 年 4 月
	…	…	…
	支持创新药高质量发展的若干措施	医保发〔2025〕16 号	2025 年 6 月
卫健委	医疗机构处方审核规范	国卫办医发〔2018〕14 号	2018 年 6 月
	关于开展药品使用监测和临床综合评价工作的通知	国卫药政函〔2019〕80 号	2019 年 4 月
	…	…	…
	关于改革完善基层药品联动管理机制扩大基层药品种类的意见	国卫药政发〔2024〕38 号	2024 年 11 月

注：表中仅列示部分来源；联合发文按制度系统归入一个部门。

资料来源：作者整理。

3.2 访谈资料

访谈资料包括专家访谈纪要（I01，记录于 2025 年 6 月 9 日）和医保专家调研纪要（I02），均由课题组整理，受访者知情并口头同意匿名引用。I01 涉及医保准入评审的机制与流程、医保体系存在的问题及政策建议，I02 涉及目录评审分层、临床价值评价及流程优化。药品监管环节主要依据公开技术文件。访谈内容与相应政策条文相互印证，仅用于阐释评价要求及跨环节实施问题，不用于检验研究结论。

4 研究方法

4.1 编码方案

本文采用医保目录调整中的安全性、有效性、经济性、创新性、公平性五维框架。《目录调整申报指南》[39]（以下简称《申报指南》）要求申报摘要按基本信息及安全性、有效性、经济性、创新性、公平性组织（经济性限目录内申报药品提供），同时适用于基本医保目录和商保创新药目录申报；《常用问答（2026 年版）》[40]（以下简称《常用问答》）亦要求多维度综合研判药

品价值。本文以该框架为统一尺度，依据各部门条文的实质内容编码，以识别药监局获益风险评价和卫健委临床综合评价中的对应内容；统一尺度仅用于描述注意力配置，不意味着三部门应采用相同的标准或权重。《管理指南》[36]原设六个维度，其中药品获取保障与可负担性内容归入公平性，适宜性按原政策含义处理；《申报指南》公平性栏目中的价格信息编码为经济性，同时涉及患者负担或获取保障的另记为公平性。

本文同时采用自动规则编码（以下简称规则编码）与大语言模型（Large Language Model，LLM）编码处理全部文本。规则编码基于领域词典与语境规则，识别表述的药品指向、适用范围及否定关系；LLM 编码采用 GPT-6.1 Sol 模型，依据完整编码手册并结合必要上下文给出五维判断与原文依据，各批独立运行且不提供人工标签或其他机器结果。词典分类的质量检验参照 Kroon 等[41]，LLM 编码参照 Gilardi 等[42]及 Halterman 和 Keith[43]。两种方法使用相同的政策原文、五维定义与纳入、排除条件。

本文以具有完整政策含义的句段为分析单元，并保留上级条款、表头及前后文，以确定表述对象与适用条件。三部门共计 4 481 条句段，其中药监局 1848 条、医保局 2 100 条、卫健委 533 条。同一句段可同时编码多个维度，如“降低患者用药负担”同时编码为经济性和公平性，而降低申报费用则不编码为公平性。

4.2 变量与指标定义

本文将五个维度分别记为 S、E、Ec、I、F。安全性指药物损害与用药风险的识别、评价和控制；有效性指防治效果、临床获益及相应证据；经济性指药品价格、费用、支付与成本效果；创新性指技术创新、实质改良及其资格评价和创新研发支持；公平性指患者按治疗需要获得并持续使用所需药品的机会与负担，一般性可及表述不构成编码依据。各维度在句段层面分别编码为 1（正类）、0 或待定，详细的纳入、排除条件及 LLM 运行设置见补充材料 A。

注意力占比按第 2.1 节定义计算，五维合计为 100%；内容覆盖比例以部门全部句段数为分母，由于同一句段可涉及多个维度，其合计不必为 100%。条件比例指涉及某一维度的句段中同时涉及另一维度的比例，用于刻画维度共现。各部门注意力占比最高的维度称为主要关注维度。以安全性句段中同时涉及有效性的比例（记为 E|S）为例，分子为两维均判为 1 的句段数，分母为安全性判为 1 且有效性可判定的句段数。各指标均基于 4 481 条全量编码计算，待定项单独保留。

4.3 编码质量检验

人工核验共纳入 466 条句段：166 条重点类别句段全部核验，另从三个部门各随机抽取 100 条，合计药监局 106 条、医保局 202 条、卫健委 158 条。重点类别涵盖药监局的经济性内容及医保局、卫健委的安全性和公平性内容，以加强对稀少类别的检验。两名编码员（一名为参与编码手册设计的作者，另一名为未参与设计、经统一培训的同课题组研究生）在不查看机器编码结果的情况下，对照原文及必要上下文独立判读全部句段的五个维度，分歧经讨论后定稿，共形成 2 330 项 0/1 人工标签。

参照 Grimmer 和 Stewart[44]针对具体研究任务开展验证的原则及 Gilardi 等[42]对照机器与人工标注的做法，本文按维度报告 Cohen κ 系数[45]、精确率、召回率及 F1 值，各指标仅在机器与人工均可作二元判断的项目上计算，机器待定项单列。两名编码员独立判读的 κ 在安全性、有效性、经济性、创新性和公平性上依次为 0.919、0.925、0.947、0.896 和 0.765，2 330 项中有 58 项不一致；按 Landis 和 Koch[46]的标准，κ 为 0.61～0.80 表示高度一致，0.81～1.00 表示几乎完全一致。比较结果见表 3。

表 3　两种编码方法与 466 条句段人工标签的比较

维度	方法	κ	精确率	召回率	F1
安全性	LLM	0.938	0.923	0.992	0.956
安全性	规则	0.706	0.913	0.672	0.774
有效性	LLM	0.960	0.948	0.989	0.968
有效性	规则	0.771	0.983	0.682	0.806
经济性	LLM	0.892	0.864	0.982	0.919
经济性	规则	0.699	0.943	0.629	0.754
创新性	LLM	0.938	0.892	1.000	0.943
创新性	规则	0.982	0.968	1.000	0.984
公平性	LLM	0.880	0.821	0.979	0.893
公平性	规则	0.799	1.000	0.689	0.816
五维合并	LLM	0.926	0.897	0.988	0.940
五维合并	规则	0.765	0.951	0.690	0.799

注：各维均以标签 1 为正类。LLM 编码和规则编码分别有 2 322 项、2 251 项有效二元判断，待定 8 项、79 项。五维合并行汇总各维度的真阳性、假阳性、假阴性和真阴性计数。各维度可判定项数、待定项数及分类计数见补充材料 C。

在 466 条核验样本中，LLM 编码在安全性、有效性、经济性和公平性四个维度的 κ 与 F1 均高于规则编码，仅创新性维度规则编码略高（表 3）。五维合并后，LLM 编码的 κ、F1 与召回率分别为 0.926、0.940 和 0.988，规则编码分别为 0.765、0.799 和 0.690，后者仅精确率略高（0.951 对 0.897）。除创新性外，规则编码其余四个维度的召回率为 0.629～0.689，约三成人工判为 1 的句段未被识别。LLM 编码在经济性和公平性上的精确率相对较低（0.864 和 0.821），故第 5.1 节和第 5.2 节另以规则编码对照。

以同一模型和编码手册对 466 条样本复跑一次（批次组成与并发设置不同于全量运行），两次结果各维度 κ 在 0.926～1.000 之间，438 条句段（93.99%）的五维判断完全一致；复跑结果与人工标签的五维合并 κ 为 0.929（原结果为 0.926），各维度 κ 在 0.876～0.954 之间，表明 LLM 编码具有较好的可重复性。

综合各维度 κ、F1 及具体判读结果，本文以 LLM 编码作为部门比较的主要依据；创新性维度两种方法的 κ 均高于 0.93，为统一五维口径亦采用 LLM 结果。规则编码作为方法对照，用于检验主要结论是否随编码方法而改变。

4.4 统计分析

稳健性分析包括三类：一是九种统计口径，涵盖条款等权、精确重复降权、剔除联合来源、剔除年度系列或多组件来源、限定 2018—2025 年完整自然年及来源等权等处理；二是逐一剔除 51 个政策来源；三是待定值边界分析，即令待定维度在 0 与 1 之间取值，计算注意力占比和条件比例的上下界。各口径定义与结果分别见补充材料 A 和 D，两种编码方法的全量对照见补充材料 E。

各维度内容覆盖比例采用 3×2 卡方检验并报告 Cramér's V（3×2 列联表中 V 与 w 相等，以 0.10、0.30 和 0.50 为小、中、大效应参考值[47]）。部门两两比较和条件比例比较采用 Fisher 确切概率法并作 Bonferroni 校正[48]，以校正后 P<0.05 为差异具有统计学意义。注意力占比、条件比例及其部门差异在部门内以政策来源为单位整群重抽样 5 000 次[49]，估计 95%置信区间（confidence interval，CI）。考虑到同一来源的句段并非相互独立，表 6 报告按来源重抽样的区间，句段重抽样区间及完整检验结果见补充材料 F。各项检验均剔除待定项。

5 研究结果

5.1 三部门的注意力配置差异

LLM 全量编码结果显示，药监局侧重安全性与有效性，两维合计占 68.38%；医保局以经济性为主，占 76.48%；卫健委的安全性（39.37%）与经济性（28.35%）占比较高（表 4、图 2）。药监局创新性占 20.96%，高于医保局（5.84%）和卫健委（3.94%），相关内容主要涉及创新药注册分类、临床价值导向和研发支持（表 5）。就含“创新药”一词的句段而言，药监局 98 条句段中创新性和安全性的注意力占比分别为 45.35%和 29.07%，医保局 144 条句段中经济性和创新性分别为 41.67%和 22.92%，卫健委组文本无此类句段。这表明两部门针对创新药的条款更突出创新性，但医保局仍以经济性居首。按是否为专门针对创新药的来源拆分后，两部门的主要关注维度均与全部来源一致（表 7）。

表 4　三部门五维注意力占比/%

部门	结果	安全性	有效性	经济性	创新性	公平性
药监局	LLM 全量	40.44	27.94	0.46	20.96	10.20
医保局	LLM 全量	6.97	6.97	76.48	5.84	3.75
卫健委	LLM 全量	39.37	16.54	28.35	3.94	11.81

注：本表为 LLM 全量编码结果。分母为本部门五个维度编码为 1 的句段数之和，未舍入的五维占比合计为 100%。60 项待定未改为 0。

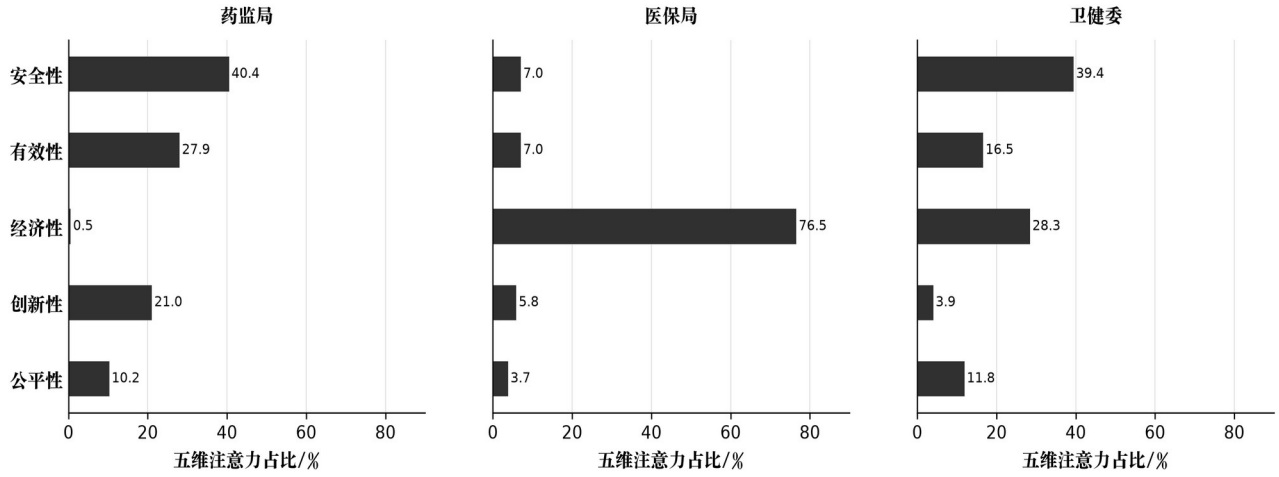


图 2　三部门五维注意力占比

注：口径同表 4，数值保留 1 位小数。

规则编码在经济性和公平性上的精确率较高（表 3），以其对照部门注意力配置，结果与 LLM 编码基本一致：药监局侧重安全性与有效性，医保局经济性占 76.87%（LLM 编码为 76.48%），卫健委安全性占比较高。在三部门两两比较的 15 项注意力占比差异中，13 项方向一致，不一致的 2 项为药监局与卫健委在安全性和公平性上的相对排序。LLM 编码下两部门安全性占比分别为 40.44%和 39.37%，公平性占比分别为 10.20%和 11.81%，差距均不足 2 个百分点，且卫健委五维标签仅 127 个，因此不认为两部门在这两个维度上存在稳定的高低关系。三部门五维内容覆盖比例见图 3。

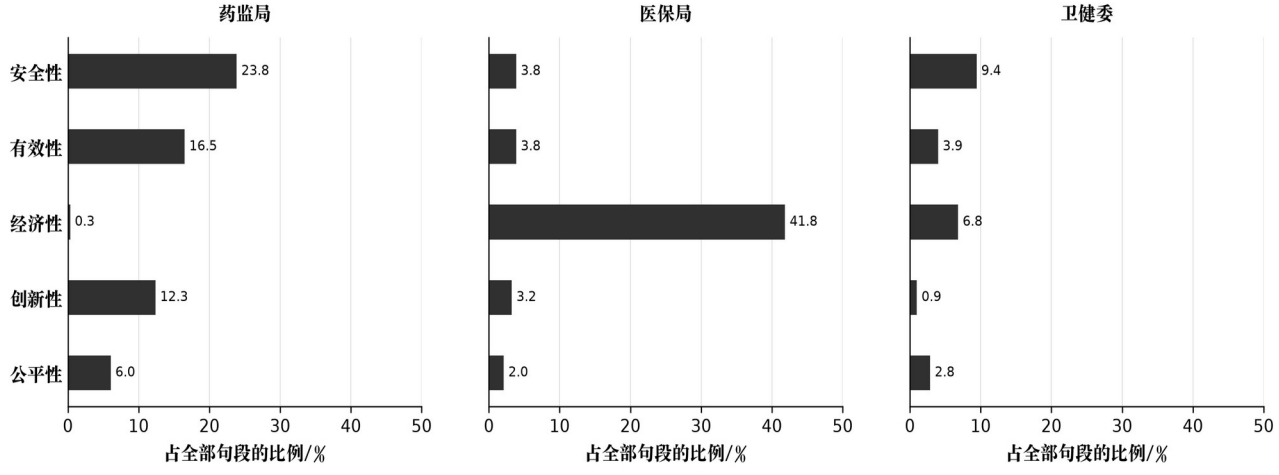


图 3　三部门五维内容覆盖比例

注：本图为 LLM 全量编码结果。分母为各部门全部句段数，五维之和不必为 100%。

需要指出的是，图 2 与图 3 的分母不同：医保局经济性句段 878 条，占全部 2 100 条句段的 41.81%（图 3），占五维标签合计 1148 个的 76.48%（图 2）。在九种统计口径及逐一剔除来源后，LLM 编码下药监局安全性居首、医保局经济性居首的结论均保持不变；卫健委按全部句段以安全性居首，但剔除联合来源或 2022 年加强用药安全管理文件后转为经济性居首。卫健委 50 条安全性句段中有 29 条来自两份联合发文，即 2022 年加强用药安全管理文件（18 条）和《医疗机构处方审核规范》（11 条）；剔除前者后，安全性与经济性句段分别为 32 条和 36 条，仅保留单独发文来源时为 8 条和 23 条。由此可知，卫健委安全性居首主要源于联合发文，该排序对来源构成较为敏感。

句段层面的检验表明，五维内容覆盖比例的部门差异均具有统计学意义（χ^2=44.44～1 107.27，P 均<0.001，Cramér's V 为 0.100～0.498）。医保局经济性占比与药监局创新性占比均高于另两部门，按政策来源重抽样的 95%CI 不含 0，且两种编码结果一致。卫健委内部安全性与经济性、药监局内部安全性与有效性的先后则无法确定（表 6）：药监局这两类句段分别集中于安全性总结资料、风险管理计划等技术文件与抗肿瘤药物研发、真实世界证据等指导原则，按来源重抽样时其先后随样本构成而变化。上述结果刻画了三部门政策文本中五维评价内容的构成，其对创新药证据准备的含义由第 5.3 节结合具体条文进一步揭示。

5.2 评价维度的共现与具体内容

安全性句段中同时涉及有效性的比例（E|S）以医保局最高：LLM 编码下医保局为 81.01%（64/79），药监局为 42.60%（187/439），卫健委为 26.00%（13/50）。医保局与另两部门的差异具有统计学意义，药监局与卫健委的差异不显著（表 6），这与卫健委分母较小且来源集中有关。该结果在规则对照与各项稳健性分析中保持不变；按完全相同文本、规范化文本和近似文本（相似度≥0.85）三种方式去除重复援引条款后，医保局 E|S 在 LLM 编码下为 76.74%～81.67%，在规则编码下为 60.00%～70.00%，均高于另两部门（补充材料表 D3）。

政策条文与访谈资料均支持上述结果。《暂行办法》第七条将安全有效、临床必需和价格合理共同列为目录准入条件[35]，《申报指南》要求说明创新带来的疗效或安全性优势[39]；I02 将安全性、有效性和经济性列为综合评审的核心内容，I01 所述综合组评价的六个维度亦涵盖上述三项。这表明，医保局较少单独论述安全性，而是将其与疗效一并作为准入条件。卫健委该比例较低，主要因其安全性句段多涉及用药错误防范与处方审核流程，在 2022 年加强用药安全管理文件和《医疗机构处方审核规范》中分别仅为 5.56%（1/18）和 9.09%（1/11）。因此，维度共现反映的是同一维度在不同任务中与其他维度的关联，而非部门之间的实际合作程度。

经济性句段中同时涉及公平性的比例（记为 F|Ec）卫健委高于医保局，但该结果对编码方法与来源构成较为敏感。在两维均可判定的句段中，LLM 编码下卫健委为 13.89%（5/36），医保局为 2.96%（26/877）；该差异经校正后具有统计学意义，但按政策来源重抽样的 95%CI 包含 0，且规则编码下不显著（表 6）。LLM 结果在九种统计口径及逐一剔除来源后方向不变，规则编码在剔除联合来源或 2024 年基层药品联动管理文件后则发生反转，原因在于共现句段少且来源集中，LLM 编码下卫健委 5 条共现句段中有 4 条来自《管理指南》（表 5）。若以公平性句段为分母（记为 Ec|F），LLM 编码下医保局为 60.47%（26/43），卫健委为 33.33%（5/15），

差异不显著（表 6）。两项比例方向相反源于分母不同：医保局经济性句段基数较大（877 条），F|Ec 相应偏低，而其保障类表述多与费用相关联，故 Ec|F 较高。

表 5　同一评价维度在三部门的具体内容

维度	药监局	医保局	卫健委
安全性	研发和上市环节的药物风险、获益风险评价及控制措施	同类药安全性比较及药品保障渠道中的用药安全	上市前后的安全性证据、处方风险与合理用药
有效性	目标患者的临床获益、试验对照与终点	与试验对照药及目录内同领域药品比较，明确支付人群	与参比药比较实际人群的健康获益，必要时开展亚组分析
经济性	真实世界经济学效益评价、试验供药及检测费用的承担	价格、治疗费、支付范围内费用、基金影响与续约	用于采购和临床资源配置的增量经济分析
创新性	创新药注册分类、临床价值导向及研发支持	创新带来的疗效与安全性优势、产品属性变化	临床需求的满足、治疗空白的填补及自主研发
公平性	优先审评临床急需短缺药品，回应供药需求	目录保障短板、患者获取药品的机会及供应、支付条件	机构药品配备、短缺情况、可获得性与家庭可负担性

资料来源：药品注册管理办法[26]、医保用药管理及申报材料[35，39，40]、临床综合评价指南[36]及对应技术文件。

药监局的安全性与有效性内容主要围绕药品研发及上市所需的获益风险证据展开。《创新药研发期间风险管理计划撰写技术指导原则（试行）》[50]要求识别影响获益风险平衡或受试者安全的风险，并制定预防、监测和治疗措施；抗肿瘤药物研发指导原则[51]要求阳性对照药反映目标患者在临床实践中的最佳治疗选择，并建议收集反映患者获益的临床终点。药监局经济性的注意力占比较低，内容包括真实医疗实践中的经济学效益评估[52]，以及 2026 年发布的《药物临床试验质量管理规范》[53]第四十五条规定的免费供药与医学检测费用责任；公平性内容主要为《药品注册管理办法》[26]第六十八条对临床急需短缺药品的优先审评安排。

医保局的经济性评价涵盖药价、治疗费用、销量预测、支付范围与基金影响。《申报指南》[39]要求目录内申报药品报告未来两年的销量与基金影响，《谈判药品续约规则》[54]依据实际药品费用与预算之比安排续约及支付标准调整。《常用问答（2025 年版）》明确支付费用监测与药品供应要求，并说明谈判药品支付标准包含基金与参保人员共同支付的费用[55]。《若干措施》[2]提出通过协商合理确定商保创新药目录内药品的结算价。卫健委《管理指南》[36]将价格水平、可获得性和可负担性共同纳入可及性评价，并以年用药治疗费用占家庭年可支配收入的比重衡量可负担性；药品监测政策[56]进一步要求共享信息、保障供应并应用评价结果。由此，经济性与公平性的关联主要体现在费用分担与支付保障、药品供应及临床使用等方面。

表 6　部门差异的统计检验

指标	比较	LLM 编码			规则编码		
		差值	95%CI	*P*	差值	95%CI	*P*
经济性占比	医保局-药监局	76.02	[67.60, 83.29]	—	76.14	[66.72, 83.49]	—
	医保局-卫健委	48.13	[32.04, 64.88]	—	49.09	[33.10, 66.94]	—
创新性占比	药监局-医保局	15.12	[5.28, 26.34]	—	18.42	[5.24, 33.59]	—
	药监局-卫健委	17.02	[6.89, 28.86]	—	19.08	[5.22, 35.65]	—

指标	比较	LLM 编码			规则编码		
		差值	95%CI	*P*	差值	95%CI	*P*
卫健委占比	安全性-经济性	11.02	[−20.00, 55.10]	—	13.33	[−18.18, 56.96]	—
药监局占比	安全性-有效性	12.50	[−1.52, 33.86]	—	12.32	[−1.29, 33.84]	—
	医保局-药监局	38.42	[16.20, 60.68]	<0.001	30.14	[6.12, 52.04]	<0.001
E|S	医保局-卫健委	55.01	[19.67, 74.07]	<0.001	43.60	[11.40, 63.22]	<0.001
	药监局-卫健委	16.60	[−22.31, 42.62]	0.071	13.46	[−21.18, 40.24]	0.430
F|Ec	卫健委-医保局	10.92	[−3.95, 24.22]	0.017	3.32	[−1.21, 23.94]	0.564
Ec|F	医保局-卫健委	27.13	[−37.84, 68.57]	0.244	5.56	[−11.11, 24.00]	1.000

注：E|S、F|Ec、Ec|F 分别为安全性句段中涉及有效性、经济性句段中涉及公平性、公平性句段中涉及经济性的比例。差值为前项减后项，单位为百分点。95%CI 为部门内按政策来源重抽样 5 000 次的 2.5%和 97.5%分位数（个别比较的有效重抽样次数略少于 5 000 次）。*P* 为双侧 Fisher 确切概率法经 Bonferroni 校正后的 *P* 值，同一条件比例内按 3 次比较校正；注意力占比中同一句段可计入多个维度，标签之间不相互独立，故未作 Fisher 检验，以“—”表示。

表 7　专门针对创新药的来源与句段的五维注意力占比/%

部门	来源范围	句段数	安全性	有效性	经济性	创新性	公平性
药监局	全部来源（17 个）	1 848	40.44	27.94	0.46	20.96	10.20
	专门来源（10 个）	597	52.07	17.62	0.00	25.91	4.40
	其他来源（7 个）	1 251	34.05	33.62	0.71	18.23	13.39
	含“创新药”一词的句段	98	29.07	13.95	0.00	45.35	11.63
医保局	全部来源（24 个）	2 100	6.97	6.97	76.48	5.84	3.75
	专门来源（5 个）	826	6.24	6.90	69.93	10.02	6.90
	其他来源（19 个）	1 274	7.44	7.01	80.69	3.15	1.72
	含“创新药”一词的句段	144	8.33	14.58	41.67	22.92	12.50

注：本表为 LLM 全量编码结果，口径同表 4，分母为各子集五维标签合计，待定项不计入。药监局专门来源指名称含“创新药”的 10 个来源（药审中心 7 个、药监局 3 个）；医保局专门来源指《若干措施》及 2025 年目录调整工作方案、2026 年目录调整工作方案、2026 年申报指南和 2026 年版常用问答 5 个来源。各子集五维标签合计依次为：药监局全部来源 1088 个、专门来源 386 个、其他来源 702 个、含“创新药”一词的句段 86 个；医保局依次为 1148 个、449 个、699 个、96 个。含“创新药”一词的句段中，药监局 98 条中有 83 条、医保局 144 条中有 139 条来自专门来源，样本量较小，相应占比仅作描述性参考。卫健委组文本中无专门来源，也未出现“创新药”一词，故未列示，这不表示卫健委未参与创新药相关联合政策。规则编码对照见补充材料表 D4、D5。

5.3 评价依据与比较药品

注意力占比与维度共现揭示了政策内容的分布特征，但同一维度仍可能服务于不同评价任务，相关结论在使用时需核对目标人群、比较药品与证据要求。本文以“比较药品”统称各环节与目标药品进行比较的药品，包括临床试验的阳性对照药（以下简称试验对照药）、医保目录调整的参照药（以下简称医保参照药）和临床综合评价的参比药（以下简称临床参比药）。以下从创新性、有效性与证据要求、价值衡量三个方面比较三部门的相关规定。

在创新性方面，药监局《化学药品注册分类及申报资料要求》[27]同时考察化合物新颖性与临床价值。医保局要求申报材料说明创新带来的疗效或安全性优势[39]，续约规则将 1 类药品注册分类用于特定条件下的谈判选择[54]。卫健委《管理指南》[36]通过与参比药的比较考察药品满足临床

需求的程度，并关注治疗空白、未满足需求及自主研发。三部门均重视创新的临床意义，但评价结论分别服务于分类注册与研发支持、支付决策以及医疗机构的药品遴选与配备。I02 指出，获得创新药注册分类并不意味着能够实现企业预期的谈判价格。因此，企业在准备后续评价材料时，应结合具体人群与比较药品阐明临床价值。

在有效性与证据要求方面，药监局抗肿瘤药物研发指南[51]要求阳性对照反映目标患者在临床实践中的最佳治疗选择。医保局《申报指南》[39]要求与试验对照药及目录内同治疗领域药品进行比较，《常用问答》[40]进一步明确参照药原则上应为临床应用最广泛的同治疗领域、同作用机制的目录内药品。卫健委《管理指南》[36]重视参比药、最佳可得研究证据及真实世界数据，必要时开展亚组分析。因此，使用既有研究结果时，应在同一人群和治疗线别下核对试验对照药、医保参照药与临床参比药的异同，判断原有证据能否直接使用或需补充比较，并据此确定后续研究的人群与比较药品。

在价值衡量方面，药监局通过获益风险判断支持上市审批与风险控制；医保局通过相对临床价值、药品费用及基金影响评估支持医保准入与支付；卫健委通过安全性、有效性及增量经济分析支持医疗机构的药品遴选、采购使用与资源配置[26，35，36]。结合 I02 关于临床价值分层与经济评价衔接的讨论，经济评价方法虽可用于不同环节，但各项评价需分别明确分析视角、成本范围、适用人群及所服务的决策。因此，不同环节可共享部分研究材料，但评价结论须依据各自的决策用途加以解释。

6 讨论

从制度逻辑视角看，三部门注意力配置的差异与其承担的决策任务相对应。药监局的科学—安全逻辑体现为对获益风险及证据充分性的重视，医保局的经济—效率逻辑体现为对相对临床价值与资源约束的关注，卫健委的公共服务逻辑则体现为对安全合理用药、药品供应与临床需求的重视。对照研究预期，药监局和医保局的结果与预期相符；卫健委安全性占比较高，但公平性占比（11.81%）与药监局（10.20%）接近，预期仅得到部分支持。这与其来源构成有关：10 个来源中有 7 个为合理用药、处方审核和医疗质量类文件，合计占其句段的 68.11%；15 条公平性句段中有 9 条来自 2024 年基层药品联动管理文件。李梦颖等[21]指出，医保控费与卫生健康部门合理用药等考核目标的部分脱嵌构成国家逻辑内部的冲突；本文则在三部门评价规则文本中观察到相应的注意力配置差异，将这一分析由政策执行环节延伸至评价规则层面。

从注意力基础观看，注意力占比与维度共现分别反映组织注意力的结构与具体情境。医保局对经济性的集中关注与其基金影响报告、续约支付标准调整等任务相对应[39，54]，在含“创新药”一词的句段中经济性仍居首；其安全性与有效性的高共现表明，在准入情境中安全性多与疗效共同构成判断条件。药监局含“创新药”一词的句段则集中于创新性，服务于注册分类与研发支持。这一发现与既有国际研究相呼应。Casilli 等[17]认为，跨国评级差异可能与证据质量在评价中的处理方式不同有关；本文显示，即使在同一国家内，不同部门对同一维度的证据要求亦存在差异。Vreman 等[28]对美欧监管与 HTA 报告的比较显示，HTA 机构对 88%～100%的药品提出相对比

较药品疗效的不确定性，监管机构仅为 12%～32%；Kållberg 等[19]在抗生素领域指出的上市评价与 HTA 之间的证据衔接困难，在我国则表现为试验对照药、医保参照药与临床参比药之间的差异（第 5.3 节）。因此，注意力占比的差异并不意味着部门间价值判断相互排斥，而是表明同一维度在不同环节承担着不同的决策功能。

上述差异意味着，创新药在某一环节形成的评价结论进入下一环节时，需要重新说明其适用条件。医保局申报要求在有效性信息中列明药审中心《技术评审报告》对本药品有效性的描述[39]，表明上市审评证据可为医保评价提供部分依据；卫健委同时评价价格与药品获取情况[36]，将支付条件与医疗机构配备、临床使用相联系。I01 反映，部分药品纳入医保目录后在医疗机构的配备与使用仍然受限，说明药品的实际应用还取决于医疗机构的临床需求与用药条件。因此，跨部门协同的重点不在于统一各部门的评价维度，而在于明确评价结论的适用条件，即针对同一人群核对比较药品，说明既有证据能够回答哪些问题、哪些问题有待补充研究。这与创新政策组合研究的认识一致：多主体治理下的协调是行动者之间的相互调适，而非由单一决策者统一安排[7]；政策组合各要素的一致性首先指不存在矛盾，并不要求各要素相同[57]。Vreman 等[28]亦主张，监管与 HTA 机构应在研发阶段共同识别下游评价关注的不确定性，商定所需证据及其生成时点。以适用条件为核心的协同，既保留了各部门依法履职所需的独立判断，又有助于减少因证据要求不清导致的重复论证，体现了兼顾评价质量与效率的质效协同取向。

从科技创新管理视角看，评价规则的可预期性是企业配置研发资源的重要前提。Rogge 和 Reichardt[57]将可预期性界定为政策工具的方向、具体规则与时序的确定程度，并指出它关系长周期研发投资面临的不确定性。企业设计临床研究、准备评价材料或安排补充研究时，需要掌握各环节对研究人群、对照选择、观察结果与分析视角的要求。若跨部门沟通能够尽早说明既有证据的适用范围与待补充的研究，企业即可将证据规划前移，在研发阶段统筹考虑准入与使用的需要。对于可共用的数据，可在质量要求相符的前提下统筹采集，各部门仍依据各自目的作出判断。在此意义上，跨部门协同为创新提供的“确定性”并非对评审结果的事先确定，而是对证据要求、比较基础与结论用途的明确。

7 跨部门协同路径与政策建议

围绕增强评价规则可预期性、促进研发—准入—使用环节质效协同的目标，结合前文对评价对象、比较药品与证据要求的比较，本文从证据准备的前端、中间和后端 3 个环节提出跨部门协同路径。三条路径均属协调安排，旨在通过加强信息流动使各部门的任务相衔接，从而增强评价过程的连贯性[57]。

7.1 完善创新药比较药品与证据要求的前置沟通

比较药品与证据要求的前置沟通位于研发证据形成与后续评价之间，是降低证据要求不确定性的前端环节。第 5.3 节表明，上市审评、医保准入与临床综合评价在比较药品选择及证据用途上存在差异，既有证据进入后续评价前，应先核对其适用条件。现行《参照药预沟通办法（试行）》[58]已允许符合条件的 1 类化学药、1 类治疗用生物制品和 1 类中成药申请推荐参照药，推荐

结果可供企业在药物经济学或真实世界研究中选用；但办法主要服务于医保目录调整和真实世界医保综合价值评价，对上市阶段试验对照药与医保参照药的差异如何说明，尚无专门规定。

本文建议从三方面加以完善。一是由企业在申请时按适应症说明研究人群、治疗线别，以及试验对照药与意向医保参照药的差异和选择理由。二是结合《申报指南》[39]要求列明的药审中心《技术评审报告》有效性描述，以及预沟通申请资料中的审评报告[58]，在反馈中明确既有证据可参照的范围及需补充论证的问题。三是依据 2026 年药品价格政策[59]对创新类别和临床价值的区分，分别说明注册分类、相对临床获益与支付评价所依据的证据。需要强调的是，预沟通旨在明确比较基础，申请品种仍需参加正式评审[60]。

7.2 依托现有评价试点统筹创新药补充研究

补充研究是衔接上市证据与支付、使用证据的中间环节。第 5.3 节表明，不同评价任务对研究人群、比较药品和观察内容的要求不同，上市后需补充的证据也应按用途加以区分。《药品注册管理办法》[26]第六十六条要求附条件批准的药品在规定期限内完成药物临床试验等相关研究，第七十六条要求持有人主动开展上市后研究；2025 年真实世界医保综合价值评价试点通知[61]提出于 2026 年建设数据库、开展评价并形成初步成果；《若干措施》[2]亦推动真实世界研究结果与目录准入、续约及支付范围调整挂钩。本文建议依托上述安排，对负有上市后研究义务或支付评价证据不足的品种分别明确待回答的问题，由企业、专业评价团队与参与医疗机构共同商定研究人群、比较药品、终点、随访期限及数据质量要求。

补充研究统筹的重点在于数据准备与研究安排的衔接。可共用的临床数据应在使用权限与质量要求相符的前提下协调采集字段和随访安排，药物警戒、医保价值评价与临床综合评价仍依据各自目的开展分析。本文建议由医保部门按试点通知统筹组织医保评价，企业履行法定上市后研究义务，参与医疗机构负责数据质量与随访；研究启动前应明确结果提交时点与证据更新方式。

在结果应用上，应区分医保价值评价与药物警戒、附条件上市研究、临床综合评价的不同用途[26，36，61]，并在既有协议与权限范围内明确新增证据用于目录续约、支付范围调整或相关评价的条件。由此，有助于减少同类数据的重复采集，在不降低评价质量要求的前提下提高证据生成与使用效率。

7.3 完善创新药临床应用反馈与证据更新衔接

临床应用是创新药价值实现的后端环节，也是识别后续研究问题的信息来源。第 6 章的讨论表明，医保准入结论尚不足以说明药品是否适合在具体临床条件下使用。《若干措施》[2]已提出研究制定创新药临床综合评价技术指南、推动创新药配备使用，2025 年基本医保目录与商保创新药目录发布通知[3]进一步明确了药品配备、临时采购与监测责任。本文建议在既有监测中区分药品未配备或无法使用的原因：对于证据不足的，明确后续评价需回答的问题；对于供应与支付问题，按现有职责协调解决；对于无适用患者或不具备用药条件的，不宜以提高使用量为目标。

在反馈机制上，医疗机构反馈适用人群、配备状态与使用条件，企业反馈供应情况，相关部门在职责范围内核对支付与保障条件。上述信息可用于制定创新药临床综合评价技术指南及开展

后续评价，并与医保评审的比较药品和证据要求相对照，识别需要补充论证的事项。需要注意的是，配备与采购信息仅反映应用条件，不能替代疗效与安全性证据；纳入商保创新药目录亦不等同于基本医保报销[3]。个体资料与保密价格信息应按授权和权限使用。由此，临床应用反馈可为企业安排后续研究提供依据，在研发、准入与使用之间形成证据持续更新的衔接机制。

8 结语

本文基于“制度逻辑—组织注意力”框架，综合运用政策文本编码、条文分析与访谈资料，比较药监局、医保局和卫健委在创新药评价中的关注差异，得出以下结论：第一，三部门政策文本的注意力配置存在差异，药监局侧重安全性与有效性，医保局侧重经济性，卫健委安全性与经济性占比较高，但二者排序受联合发文影响。在含“创新药”一词的条款中，药监局突出创新性，医保局仍以经济性居首。第二，同一维度下三部门的评价对象、比较药品与证据要求各不相同，既有证据能否用于后续环节，需结合目标人群、比较基础及决策用途加以判断；跨环节使用评价结论时，应说明既有证据能够支持的判断及仍需补充的问题。

本文的边际贡献主要体现在两方面：一是将科技创新政策研究中的创新链视角引入创新药评价研究，在统一的五维框架下同时比较药品注册、医保准入与临床使用三个环节，并以维度共现揭示注意力占比之外的信息；二是从证据适用条件出发阐释部门评价差异对企业的含义，指出跨部门协同为创新提供的确定性主要体现为证据要求、比较基础与结论用途的明确。在实践层面，尽早明确比较药品与证据要求、统筹补充研究、利用临床应用反馈识别待研究问题，能够在保障评价质量的同时提高证据使用效率，增强评价规则对企业的可预期性，促进创新药研发、准入与使用环节的质效协同。

本研究的局限主要在于：注意力占比刻画的是政策文本中各维度内容的比重，与评审中的实际权重未必一致[32]；卫健委来源较少，且《管理指南》中的适宜性未作为独立维度统计。未来研究可扩充卫健委及地方层面文本、对适宜性单独编码，并结合评审、配备与用药数据考察政策文本注意力配置与实际执行之间的关系。

参考文献

[1]中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要[Z]. 2026.

[2]国家医疗保障局, 国家卫生健康委员会. 国家医保局 国家卫生健康委关于印发《支持创新药高质量发展的若干措施》的通知：医保发〔2025〕16号[EB/OL]. (2025-07-01)[2026-10-31]. https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/7/1/art_104_17058.html.

[3]国家医疗保障局, 人力资源社会保障部. 关于印发《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录》以及《商业健康保险创新药品目录》（2025年）的通知: 医保发〔2025〕33号[EB/OL]. (2025-12-07)[2026-10-08]. https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/12/7/art_53_18971.html.

[4]吴佳佳. 医保商保“双目录”大力支持创新——好药新药加速惠及百姓[EB/OL]. 新华网, (2026-01-03)[2026-10-26]. https://www.news.cn/fortune/20260103/a458cb7c27b3499c823fc43b29777a3e/c.html.

[5]戴小河. 国家药监局：助力创新药“中国首发”[EB/OL]. (2026-01-07)[2026-10-26]. https://www.nmpa.gov.cn/yaowen/ypjgyw/zhyw/20260108085003119.html.

[6]国家医疗保障局. 国家医保局 人力资源社会保障部印发 2025 年版国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录和商业健康保险创新药品目录 [EB/OL]. (2025-12-07)[2026-10-26]. https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/12/7/art_14_18972.html.
[7]Flanagan K, Uyarra E, Laranja M. Reconceptualising the ‘policy mix’ for innovation[J]. Research Policy, 2011, 40(5): 702-713.
[8]孔繁翠. 创新药价值评估的国际经验比较及启示[J]. 中国卫生政策研究, 2022, 15(6): 17-23.
[9]赵华婷, 颜建周, 邵蓉. 法国临床效益评价对我国创新药医保目录动态调整的启示[J]. 中国卫生经济, 2019, 38(5): 94-96.
[10]艾丹丹, 陈辰, 吴婷婷, 等. 价值医疗背景下创新药品的定价和支付模式综述[J]. 中国卫生经济, 2020, 39(3): 77-79.
[11]王恩楠, 朱铭来. 我国专利药品医疗保险价格谈判的演化博弈研究[J]. 中国卫生政策研究, 2023, 16(2): 44-51.
[12]谭清立. 医保谈判政策对生物医药企业创新投入的影响机制分析[J]. 科技管理研究, 2025, 45(3): 120-127.
[13]吕倩鹏, 吴红, 刘智勇. 政策工具视角下我国创新药物研发政策量化研究[J]. 中国卫生事业管理, 2024, 41(12): 1393-1399.
[14]刘仁济, 杨得前, 许露. 政策工具视角下的中国科技成果转化政策变迁[J]. 科研管理, 2025, 46(9): 126-135.
[15]宋娇娇, 徐芳, 孟溦. 中国科技评价政策的变迁与演化：特征、主题与合作网络[J]. 科研管理, 2021, 42(10): 11-19.
[16]洪银兴. 围绕产业链部署创新链——论科技创新与产业创新的深度融合[J]. 经济理论与经济管理, 2019, 39(8): 4-10.
[17]Casilli G, Lidonnici D, Jommi C, et al. Do France, Germany, and Italy agree on the added therapeutic value of medicines?[J]. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 2023, 39(1): e54.
[18]Garau M, Hampson G, Devlin N, et al. Applying a multicriteria decision analysis (MCDA) approach to elicit stakeholders’ preferences in Italy: The case of obinutuzumab for rituximab-refractory indolent non-Hodgkin lymphoma (iNHL)[J]. PharmacoEconomics Open, 2018, 2(2): 153-163.
[19]Kållberg C, Mathiesen L, Gopinathan U, et al. The role of drug regulatory authorities and health technology assessment agencies in shaping incentives for antibiotic R&D: A qualitative study[J]. Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, 2023, 16: 53.
[20]Mundy L, Forrest B, Huang L Y, et al. Health technology assessment and innovation: Here to help or hinder?[J]. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 2024, 40(1): e37.
[21]李梦颖, 伍琳, 王昕妍, 等. 我国医保谈判药品落地问题的多重制度逻辑分析与政策建议[J]. 中国药房, 2024, 35(14): 1683-1689.
[22]蔡乾和, 陶蕊, 张一粟, 等. 公共科技成果价值评价的理论基础构建[J]. 科技管理研究, 2023, 43(3): 53-59.
[23]He A J, Bali A S, Ramesh M. Active stewardship in healthcare: Lessons from China’s health policy reforms[J]. Social Policy & Administration, 2022, 56(6): 925-940.
[24]Guo W, Wang P, Zhang Y, et al. Health technology assessment in China’s health care sector: Development and applications[J]. Health Systems & Reform, 2023, 9(3): 2327099.
[25]马文聪, 叶阳平, 陈修德. 创新政策组合：研究述评与未来展望[J]. 科技进步与对策, 2020, 37(15): 152-160.
[26]国家市场监督管理总局. 药品注册管理办法: 国家市场监督管理总局令第 27 号[Z]. 2020.
[27]国家药品监督管理局. 化学药品注册分类及申报资料要求[Z]. 2020.
[28]Vreman R A, Naci H, Goettsch W G, et al. Decision making under uncertainty: Comparing regulatory and health technology assessment reviews of medicines in the United States and Europe[J]. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 2020, 108(2): 350-357.
[29]Thornton P H, Ocasio W. Institutional logics[M]//Greenwood R, Oliver C, Sahlin K, et al. The SAGE handbook of organizational institutionalism. London: SAGE, 2008: 99-129.

[30]Ocasio W. Towards an attention-based view of the firm[J]. Strategic Management Journal, 1997, 18（S1）: 187-206.
[31]练宏. 注意力分配——基于跨学科视角的理论述评[J]. 社会学研究, 2015, 30(4): 215-241+246.
[32]曾润喜, 莫敏丽. 政府注意力的测量: 路径、内容与展望[J]. 华中科技大学学报（社会科学版）, 2023, 37(1): 66-73.
[33]文宏. 中国政府推进基本公共服务的注意力测量——基于中央政府工作报告（1954—2013）的文本分析[J]. 吉林大学社会科学学报, 2014, 54(2): 20-26+171.
[34]陈星平, 毕利娜, 吴道友. 中国政府推进科技人才创新创业的注意力测量——中央政府工作报告（1978—2017）文本分析[J]. 科技进步与对策, 2018, 35(23): 155-160.
[35]国家医疗保障局. 基本医疗保险用药管理暂行办法: 国家医疗保障局令第1号[Z]. 2020.
[36]国家卫生健康委办公厅. 药品临床综合评价管理指南（2021年版 试行）: 国卫办药政发〔2021〕16号附件[Z]. 2021.
[37]人力资源社会保障部. 关于将36种药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知：人社部发〔2017〕54号[EB/OL]. (2017-07-13)[2026-10-31]. https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/shehuibaozhang/zcwj/yiliao/201707/t20170718_274153.html.
[38]中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见[EB/OL]. (2017-10-08)[2026-10-31]. https://app.www.gov.cn/govdata/gov/201710/08/413100/article.html.
[39]国家医疗保障局. 2026年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整申报指南[Z]. 2026.
[40]国家医疗保障局. 国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整常用问答（2026年版）[Z]. 2026.
[41]Kroon A C, van der Meer T, Vliegenthart R. Beyond counting words: Assessing performance of dictionaries, supervised machine learning, and embeddings in topic and frame classification[J]. Computational Communication Research, 2022, 4(2): 528-570.
[42]Gilardi F, Alizadeh M, Kubli M. ChatGPT outperforms crowd workers for text-annotation tasks[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2023, 120(30): e2305016120.
[43]Halterman A, Keith K A. Codebook LLMs: Evaluating LLMs as measurement tools for political science concepts[J]. Political Analysis, 2026, 34(2): 188-204.
[44]Grimmer J, Stewart B M. Text as data: The promise and pitfalls of automatic content analysis methods for political texts[J]. Political Analysis, 2013, 21(3): 267-297.
[45]Cohen J. A coefficient of agreement for nominal scales[J]. Educational and Psychological Measurement, 1960, 20(1): 37-46.
[46]Landis J R, Koch G G. The measurement of observer agreement for categorical data[J]. Biometrics, 1977, 33(1): 159-174.
[47]Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences[M]. 2nd ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.
[48]Dunn O J. Multiple comparisons among means[J]. Journal of the American Statistical Association, 1961, 56(293): 52-64.
[49]Field C A, Welsh A H. Bootstrapping clustered data[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology), 2007, 69(3): 369-390.
[50]国家药品监督管理局药品审评中心. 创新药研发期间风险管理计划撰写技术指导原则（试行）: 国家药监局药审中心通告2025年第38号附件[Z]. 2025.
[51]国家药品监督管理局药品审评中心. 以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则[Z]. 2021.
[52]国家药品监督管理局. 真实世界证据支持药物研发与审评的指导原则（试行）[Z]. 2020.
[53]国家药品监督管理局, 国家卫生健康委员会. 药物临床试验质量管理规范（2026年修订）[Z]. 2026.

[54]国家医疗保障局. 谈判药品续约规则[EB/OL]//国家医疗保障局. 国家医疗保障局发布《2026 年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》等相关文件：附件 3. (2026-05-31)[2026-10-19]. https://www.nhsa.gov.cn/art/2026/5/31/art_109_20816.html.
[55]国家医疗保障局. 国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整常用问答（2025 年版）[EB/OL]//国家医疗保障局. 国家医疗保障局关于公布《2025 年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》等相关文件的公告：附件 5. (2025-07-10)[2026-10-08]. https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/7/10/art_109_17198.html.
[56]国家卫生健康委. 关于开展药品使用监测和临床综合评价工作的通知：国卫药政函〔2019〕80 号[EB/OL]. (2019-04-09)[2026-10-21]. https://www.nhc.gov.cn/yaozs/c100097/201904/6bc8f273684845d3ab76fed841eb42d2.shtml.
[57]Rogge K S, Reichardt K. Policy mixes for sustainability transitions: An extended concept and framework for analysis[J]. Research Policy, 2016, 45(8): 1620-1635.
[58]国家医疗保障局. 国家医保局发布《参照药预沟通办法（试行）》[EB/OL]. (2026-02-10)[2026-10-08]. https://www.nhsa.gov.cn/art/2026/2/10/art_109_19642.html.
[59]国务院办公厅. 关于健全药品价格形成机制的若干意见：国办发〔2026〕9 号[EB/OL]. (2026-04-14)[2026-10-31]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065542.htm.
[60]国家医疗保障局. 2026 年药品目录调整工作方案解读活动文字实录[EB/OL]. (2026-05-26)[2026-10-08]. https://www.nhsa.gov.cn/art/2026/5/26/art_14_20707.html.
[61]国家医疗保障局办公室. 关于开展真实世界医保综合价值评价试点工作的通知：医保办发〔2025〕15 号[EB/OL]. (2025-09-23)[2026-10-08]. https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/9/23/art_109_17984.html.

作者简介：王孝炯（1982—，通信作者），男，安徽合肥人，博士研究生，中国科学院科技战略咨询研究院创新研究员，主要研究方向为创新发展政策；陈海婷（2002—），女，福建建瓯人，硕士研究生，主要研究方向为科技创新管理与政策；刘中全（1988—），男，河南郸城人，硕士研究生，国家发展改革委创新驱动发展中心处长、副研究员，主要研究方向为生物经济、生物医药、生物制造及未来产业、科技创新政策等。